THORAX · TH-02

Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022

ACR Lung-RADS v2022 · ACR AC Indolent 2026
scanner faible dose de dépistage

CATÉGORIES LUNG-RADS V2022 (SCANNER FAIBLE DOSE DE DÉPISTAGE)

CATÉGORIE	NODULE SOLIDE	PARTIELLEMENT SOLIDE	VERRE DÉPOLI	CONDUITE
0 incomplet	Examen antérieur à récupérer, poumon non évaluable, ou aspect infectieux/inflammatoire (consolidation, > 6 nouveaux nodules, gros nodule apparu rapidement)			Comparaison ou scanner à 1–3 mois
1 négatif	Pas de nodule, ou nodule à calcification bénigne ou graisse			Scanner à **12 mois**
2 bénin	< 6 mm ; nouveau < 4 mm ; juxtapleural typique < 10 mm	< 6 mm au total	< 30 mm, ou ≥ 30 mm stable ou à croissance lente	
3 probablement bénin	6–< 8 mm initial ; nouveau 4–< 6 mm	≥ 6 mm au total, composante solide < 6 mm ; nouveau < 6 mm au total	≥ 30 mm initial ou nouveau	Scanner à **6 mois**
4A suspect	8–< 15 mm initial ; croissance < 8 mm ; nouveau 6–< 8 mm	Composante solide 6–< 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide < 4 mm	—	Scanner à **3 mois** ; TEP-TDM si solide ≥ 8 mm
4B très suspect	≥ 15 mm initial ; nouveau ou croissant ≥ 8 mm	Composante solide ≥ 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide ≥ 4 mm	—	Scanner diagnostique ± injection, TEP-TDM, prélèvement ; avis RCP
4X	Catégorie 3 ou 4 avec signe supplémentaire suspect (spiculations, adénopathie, aspect évolutif…)			

Croissance : augmentation du diamètre moyen **> 1,5 mm** en 12 mois. Diamètre moyen arrondi à 0,1 mm (et non plus au mm). Nodule à croissance lente sur plusieurs examens sans franchir le seuil : 4B possible (solide ou partiellement solide), 2 pour un verre dépoli.

NOUVEAUTÉS V2022

Kystes atypiques

- 4A paroi épaisse (≥ 2 mm) ou multiloculé
- 4B croissance de la paroi ou des cloisons, plus de loges ou de densité
- 3 kyste à paroi épaisse stable dont la composante kystique croît
- Kyste uniloculaire à paroi fine : hors Lung-RADS

Nodules des voies aériennes

- 2 sous-segmentaire, ou aspect bénin (air, absence de tissu)
- 4A nodule endotrachéal ou endobronchique solide, segmentaire ou plus proximal
- 4B persistant au scanner à 3 mois → bronchoscopie

Prise en charge « par paliers »

- 4A stable à 3 mois → 3, scanner à 6 mois
- 3 stable à 6 mois → 2, scanner à 12 mois
- Délais comptés depuis la date de l'examen en cours
- 4B prouvé bénin → reclasser selon le nodule le plus suspect

MODIFICATEUR S ET CAS PARTICULIERS

S
découverte significative non pulmonaire (coronaires, emphysème, masse…) ; inutile si déjà connue ou traitée

Cavité
si la partie tissulaire dépasse la cavité : classer comme nodule tissulaire

Juxtapleural
solide, ≤ 10 mm, lisse, triangulaire, lentiforme ou ovale (périscissural, costal, médiastinal, diaphragmatique) → 2

Plusieurs nodules
la catégorie finale suit le nodule le plus suspect

CANCER PULMONAIRE INDOLENT · NOUVEAU CRITÈRE ACR 2026

ACR AC « Indolent Lung Cancer » (JACR, oct. 2026) — Les nodules subsolides persistants ou à croissance lente et les **kystes atypiques** représentent souvent des formes indolentes de cancer du poumon. Leur prise en charge se décide en **staff multidisciplinaire** (risque, histoire naturelle, options thérapeutiques, préférences du patient).

Surveillance différée

- Si le staff préfère la surveillance à l'intervention : **scanner thoracique sans injection**, aux intervalles Lung-RADS/Fleischner
- Objectif unique : **détecter les changements qui modifieraient la conduite** — croissance de la composante solide, nouveaux nodules, nouveaux signes
- La radiographie ne surveille pas les lésions subsolides

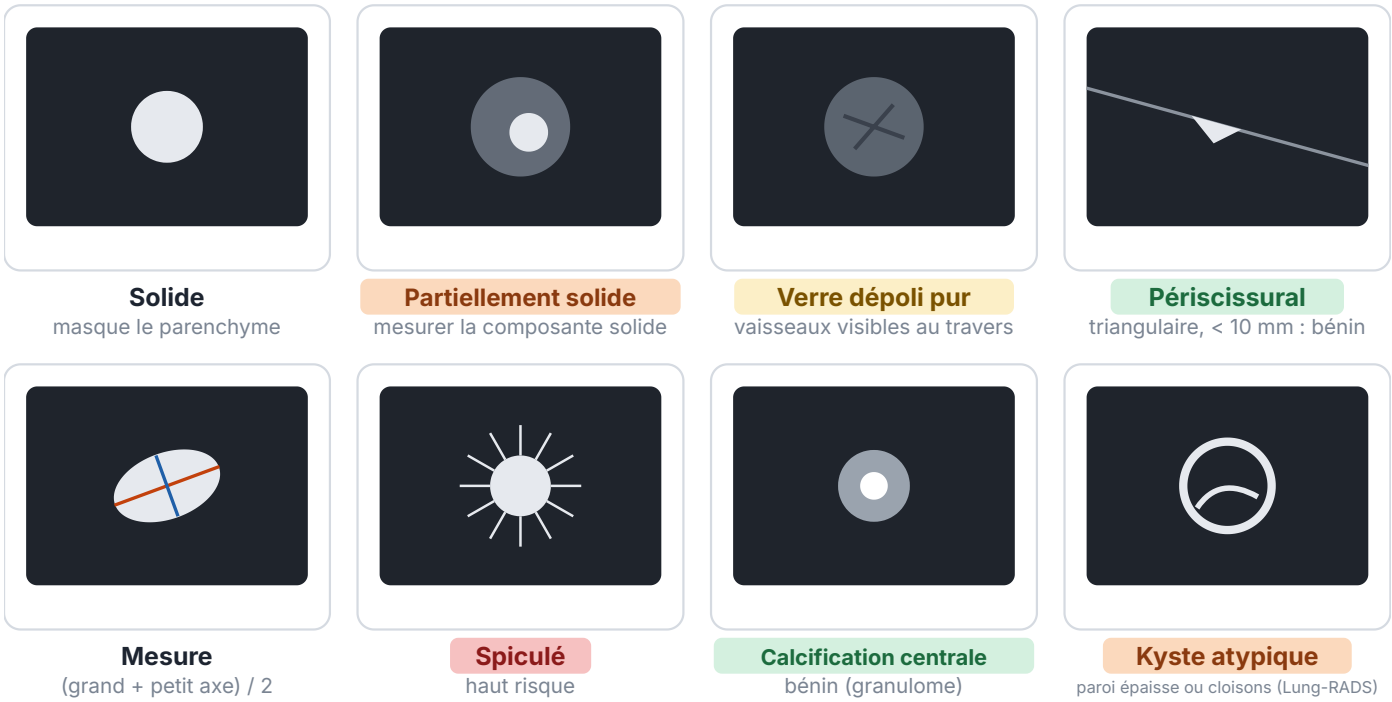
Si le traitement est décidé

- Le **bilan d'imagerie diagnostique** (scanner ± injection, TEP-TDM) et la **biopsie** sont alors indiqués
- Ils **ne font pas partie de la surveillance** : les séparer clairement dans le compte rendu et le programme de suivi
- Choix de la modalité selon ce qui **modifiera la décision de traiter**

Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022 (suite)

ATLAS VISUEL

Types de nodules et mesure



Solide
masque le parenchyme

Partiellement solide
mesurer la composante solide

Verre dépoli pur
vaisseaux visibles au travers

Périscissural
triangulaire, < 10 mm : bénin

Mesure
(grand + petit axe) / 2

Spiculé
haut risque

Calcification centrale
bénin (granulome)

Kyste atypique
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

Mêmes types de nodules que pour Fleischner ; en dépistage, la catégorie dépend de la taille et du type (voir le tableau).

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Lung-RADS
Radiopaedia · catégories v2022
radiopaedia.org/articles/lung-rads

Dépistage du cancer du poumon
Radiopaedia · essais et population
radiopaedia.org/articles/lung-cancer-screening?l

Nodule en verre dépoli
Radiopaedia · aspects
radiopaedia.org/articles/ground-glass-density-no

Lung-RADS v2022 (ACR, PDF)
Tableau officiel
cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung

Sources : ACR Lung-RADS v2022 Summary – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung-RADS-2022-S... · Lung-RADS v2022 (Dartmouth) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · ACR AC Indolent Lung Cancer 2026 (PubMed) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42573542/ · ACR AC Indolent Lung Cancer (JACR, oct. 2026) – doi.org/10.1016/j.jacr.2026.07.003